Grupo 5 - Desafio Produto PTC 26.2

Ana Beatriz, Bruno Rodrigues, Gabriel Stamford Arnaud, Giovanna Reis, João Neves e Tom Nogueira

1. Resumo para o Ricardo

O prejuízo mensal de R$18.225,90 com consultas não realizadas na Clínica Movimento não é provocado pelo esquecimento dos pacientes, já que é um motivo de apenas 13% dos abandonos. A causa primária é a ruptura na renovação do convênio na 5ª sessão, onde o no-show salta de 18% para 44%, somada à percepção de cura precoce (30,4%). A proposta da agência dos R$15 mil + R$400/mês em lembretes ataca a causa errada. Propomos uma solução focada na renovação antecipada na 3ª sessão e lista de espera ativa, viável dentro do limite de R$20 mil e 10 semanas de squad.

2. O problema de verdade

Causas Principais das Faltas

1. **Demora na renovação do Convênio quebra o tratamento na 6ª sessão**

Dados: no convênio, a falta vai de 18% na 5ª sessão para 44% na 6ª. Já no particular, vai de 13% para 16%. Nas sessões 1 a 5, a diferença entre os dois era de 1 a 5 pontos e na 6ª ela pula para 28 pontos e continua entre 11 e 19 pontos nas sessões 7 a 10.

Falas que sustentam: Joana explicou que o convênio libera 5 sessões por vez e que a renovação leva de 3 a 10 dias úteis, por isso o horário do paciente não fica reservado. A Dona Célia diz que esperou cerca de 10 dias, perdeu o horário das 10h e só sobraram 7h ou 18h, que fica inviável para ela. Na pesquisa, 5 de 23 pessoas, cerca de 22% apontaram a demora do convênio para a renovação das últimas sessões.

2. **O paciente melhora e acha que não precisa terminar**

Quando a dor passa, o paciente sente que o tratamento acabou e ninguém explica por que as últimas sessões importam, ou acaba não dando tempo para isso.

Dados: nos dois tipos de paciente a falta sobe a cada sessão. No particular vai de 6% na 1ª para 27% na 10ª, e no convênio de 7% para 38%, com o salto da 6ª no meio. Isso é o esperado se a vontade de continuar cai conforme a dor passa.

Falas que sustentam: Paulo disse que, quando a dor some, o paciente acha que acabou e ninguém explica por que as últimas sessões importam. A Dona Célia contou que ninguém

explicou e a dor voltou. Na pesquisa, “já estava melhor” e “achou que não estava adiantando” somam 9 de 23 pessoas, cerca de 39%, o maior grupo.

3. **Incompatibilidade de horários nas pontas do dia e trânsito**

Quem só consegue horários muito cedo ou no fim do dia acaba faltando mais. Essa causa se mistura com a primeira, porque a renovação do convênio empurra o paciente justamente para esses horários.

Dados: em Boa Viagem, 7h–9h tem 33% de falta e 17h–20h tem 32%, contra 17–18% no meio do dia. Em Casa Forte o padrão se repete, só que menor: 22% e 20%, contra 12–13%. Esses dados por faixa de horário vêm da tabela de faltas por horário do enunciado.

Falas que sustentam: Marcos disse que chegar em Boa Viagem às 18h é impossível e pediu sábado, que não possui horário. Já a Dona Célia não conseguia ir às 7h nem às 18h, por não ter quem a levasse. Na pesquisa, 5 de 23 pessoas, cerca de 22%, citaram horário ou trânsito. A demora na renovação do convênio pode provocar a perda do horário habitual do paciente, levando-o a enfrentar dificuldades de horário e deslocamento. Assim, embora sejam motivos registrados separadamente, podem estar interligados. O relato de Dona Célia reforça essa hipótese, embora os dados não permitam quantificar essa relação.

4. **Esquecimento**

Nas 2 semanas sem lembrete em Boa Viagem, a falta foi só 3 pontos maior (27% contra 24%), mostrando que mesmo que haja essa causa, não é a mais relevante nesse caso.

Dados: Na pesquisa, “esqueci” teve 3 de 23 respostas, cerca de 13%. Porém, o teste durou só 2 semanas e foi em uma unidade, então o efeito pode ser pequeno ou o teste curto demais para mostrar mais.

Falas que sustentam: Joana disse que “não mudou tanto” quando ela tirou férias em julho e ninguém enviou os lembretes para os clientes e a Dona Célia contou que nunca esqueceu nenhuma sessão.

Divergência entre fontes

1. **Causa primeira das faltas**

Posição do cliente: Ricardo acredita que o motivo principal é o esquecimento.
Evidência de dados e entrevistas: A pesquisa indica 13% de esquecimento contra 39,1% de melhora/falta de orientação e 21,7% de demora de convênio.

2. **Agilidade do Convênio**

Posição do cliente: Ricardo afirma que o convênio libera as sessões rapidamente.
Evidência de dados e entrevistas: Joana e Dona Célia relatam prazos de 3 a 10 dias úteis, e o salto de faltas de 18% para 44% na 6ª sessão comprova a ruptura.

3. Jornada do usuário

3.1. Mapeamento das Dores

Dono (Ricardo):

- **Como é afetado:** Sofre com a perda financeira provocada por cadeiras vazias enquanto mantém o custo fixo do salário dos fisioterapeutas. Precisa entender os motivos do abandono do tratamento e as discrepâncias operacionais entre as duas unidades.
- **O que precisa:** Relatórios consolidados sobre taxa de ocupação, índice de faltas e impacto financeiro real. Necessita comparar a sua percepção com os dados operacionais para fundamentar decisões estratégicas dentro do limite de R$20 mil em até 3 meses.

Pacientes (Convênio e Particular):

- **Como são afetados:** Faltam com frequência por desconhecerem a importância anatômica de concluir o tratamento de 10 sessões, com desmotivação agravada pela ausência da dor nas sessões intermediárias. Pacientes de convênio enfrentam o represamento da autorização na 5ª sessão, perdendo o horário fixo. Ambos os perfis relatam gargalos de trânsito e horários inconvenientes.
- **O que precisam:** Acompanhamento e orientação sobre a continuidade do tratamento, facilidade no reagendamento de consultas com flexibilidade de horários e solicitação antecipada da renovação do convênio sem pausa no tratamento.

Recepcionista (Joana):

- **Como é afetada:** Enfrenta sobrecarga de trabalho manual, dedicando cerca de três horas diárias ao atendimento via WhatsApp, agendamentos por telefone, confirmações individuais e acompanhamento de autorizações que demoram de 3 a 10 dias úteis.
- **O que precisa:** Ferramenta centralizada de agendamento e acompanhamento de guias que automatize tarefas repetitivas e diferencie cancelamento prévio de falta sem aviso.

Fisioterapeutas (Paulo em BV e Lúcia em CF):

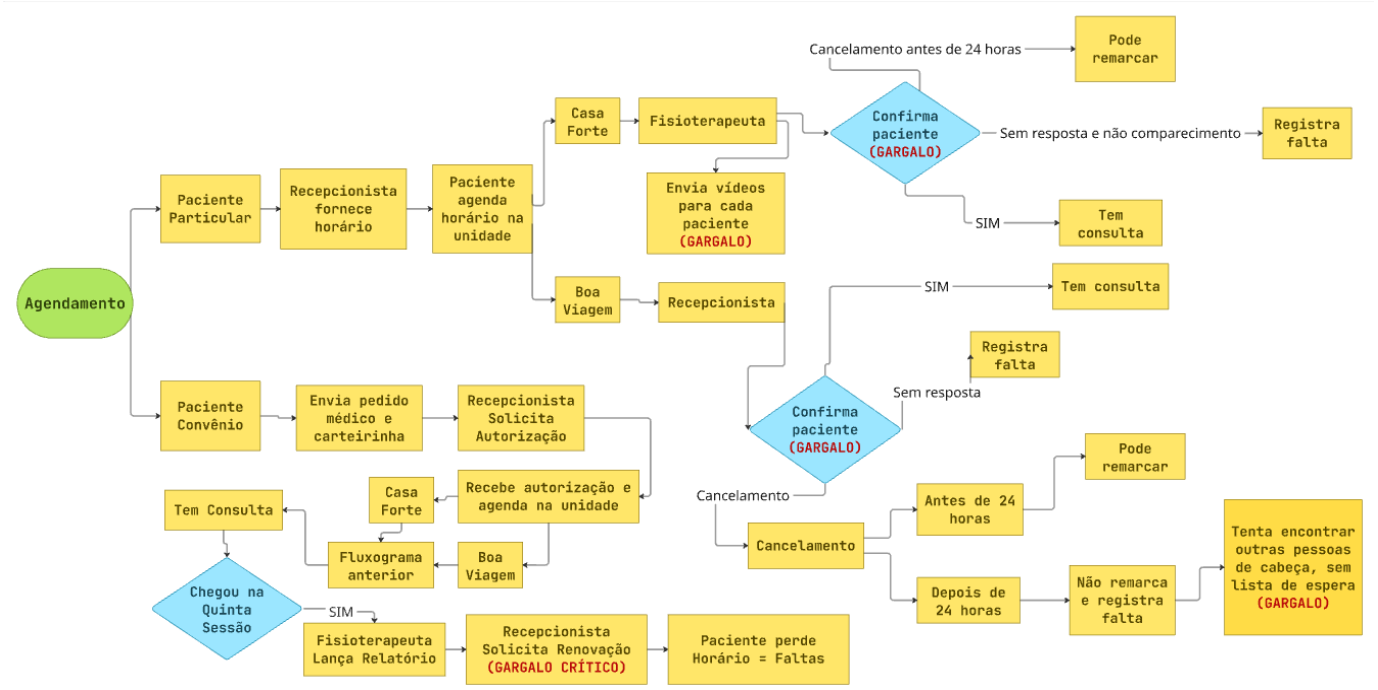
- **Como são afetados:** Em Casa Forte, a profissional assume informalmente a gestão do paciente e o envio de vídeos via WhatsApp, gerando sobrecarga não escalável. Em Boa Viagem, a rotina corrida impede o fisioterapeuta de orientar o paciente sobre a conclusão do ciclo.
- **O que precisam:** Um processo institucional de engajamento e educação do paciente conduzido pela clínica, liberando o profissional para focar exclusivamente no atendimento clínico.



4. Fluxo as-is e to-be

Fluxo as-is

Link (MIRO): https://miro.com/app/board/uXjVESZdLBI=/?share_link_id=540248184666



Fluxo to-be

TO_BE_clinica_revisado.pdf

5. Os números

5.1. Quanto as Faltas Custam por Mês em Cada Unidade

Como os fisioterapeutas recebem salário fixo independentemente do comparecimento dos pacientes, cada falta representa uma oportunidade direta de faturamento perdida, sem redução de custo operacional.

Indicador	**Boa Viagem**	**Casa Forte**
Sessões agendadas/mês	600	420
Taxa de faltas	25%	17%
Faltas estimadas/mês	150	71,4
Receita média por sessão	R$77,00	R$93,50
Faturamento perdido/mês	R$11.550,00	R$6.675,90
Impacto financeiro mensal estimado da rede	**R$18.225,90**	
Projeção anual	**R$218.710,80**	

Boa Viagem concentra a maior taxa de absenteísmo (25%) e responde por cerca de **63,4% do prejuízo financeiro total da rede**, devendo ser o foco prioritário das ações.

5.2. Diferença e registro entre as unidades

À primeira vista, Boa Viagem apresenta 8 pontos percentuais a mais de faltas do que Casa Forte (25% contra 17%). No entanto, a comparação direta não é adequada porque as unidades possuem critérios e perfis operacionais distintos:

1. **Divergência nos critérios de registro de faltas:**

Em Boa Viagem, cancelamentos realizados com menos de 24 horas de antecedência são contabilizados formalmente como faltas.

Em Casa Forte, apenas o absenteísmo total (paciente que não comparece sem avisar) é registrado como falta.

Resultado: Identificou-se que parte das faltas de Boa Viagem é, na verdade, desmarcação tardia. Esse tipo de ocorrência exige uma solução de lista de espera ativa (inexistente hoje) para preencher vagas em cima da hora.

2. **Diferença no perfil de pacientes (Convênio vs. Particular):**

A taxa média de faltas no convênio é de 25,2%, enquanto no particular é de 15,5%.

Considerando a composição da carteira de clientes, a taxa esperada de faltas é de aproximadamente 21,3% em Boa Viagem e 18,4% em Casa Forte.

Resultado: O perfil da carteira de clientes explica sozinho cerca de 3 dos 8 pontos percentuais de diferença entre as unidades.

3. **Concentração da Agenda em Horários de Pico:**

Boa Viagem concentra 45% de suas sessões nas pontas do dia (7h–9h e 17h–20h), faixas com maior incidência de atrasos e faltas.

Casa Forte possui 35% da agenda nesses horários.

Resultado: A distribuição da grade horária explica cerca de 1,5 ponto percentual da diferença.

4. **Método de Confirmação e Acompanhamento:**

Em Boa Viagem, a confirmação é feita manualmente pela recepção.

Em Casa Forte, os fisioterapeutas confirmam individualmente e enviam vídeos de exercícios entre as sessões.

Conclusão: O critério de registro, o perfil de convênio e o mix de horários justificam grande parte dos 8 pontos de divergência. Como esses fatores se sobrepõem, seus efeitos não podem ser simplesmente somados. A diferença remanescente decorre do acompanhamento personalizado, do trânsito local ou de variáveis não isoladas nos relatórios.

5.3. O que os dados não permitem afirmar

Os dados disponíveis não permitem determinar:

- Quantas das 150 faltas mensais de Boa Viagem correspondem a cancelamentos tardios ou ausências sem aviso.
- O impacto isolado do acompanhamento individual dos fisioterapeutas sobre a redução das faltas em Casa Forte.
- O tempo exato de renovação dos convênios e sua relação com a perda dos horários habituais.
- A quantidade de pacientes que abandonam o tratamento após a 5ª sessão sem agendar a próxima consulta.
- A demanda real e a viabilidade financeira de atendimentos aos sábados.

6. A solução e o protótipo

Plataforma Web de Gestão Integrada

A solução proposta pelo squad é o desenvolvimento de uma plataforma web centralizada para a gestão das clínicas, integrada a um sistema de automação via WhatsApp. O sistema foi projetado com controle de acesso por perfil (RBAC), garantindo que cada usuário interaja apenas com as ferramentas essenciais para a sua rotina diária.

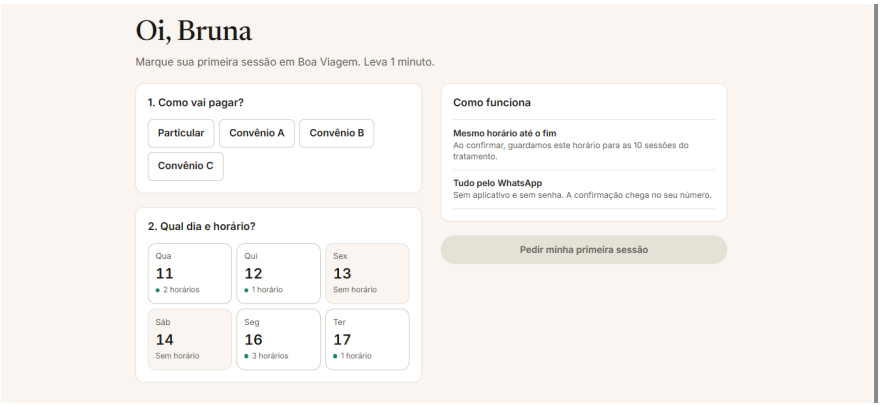
https://claude.ai/artifact/95hUeNYEj5G5E8zxuGHbrD

WhatsApp automatizado para clientes e, se necessário, para responsáveis



Canal direto de comunicação com o paciente e, quando indicado, com seu responsável. Permite confirmação ativa, reagendamento e acompanhamento transparente da renovação do convênio.

Aba de registro para novos clientes



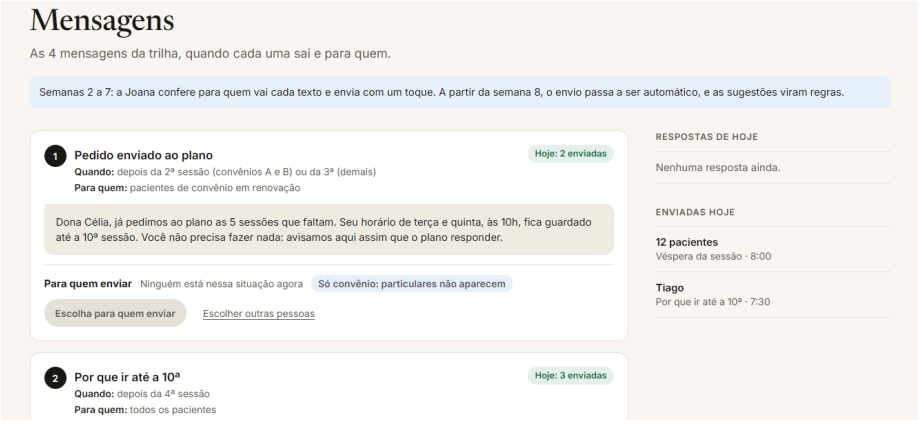
Formulário web simples para autoatendimento, onde o cliente seleciona a unidade, a modalidade de pagamento - particular ou convênio e envia a documentação necessária em menos de um minuto.

Aba principal para recepcionistas



Central de controle operacional com alertas visuais prioritários: vagas abertas por cancelamentos tardios, lembrete para pedir laudo de evolução ao fisioterapeuta na 2ª/3ª sessão e status em tempo real das guias nos convênios.

Aba para mensagens automáticas



Painel de gestão da trilha de engajamento e orientação clínica. Entre as semanas 2 e 7, o envio é assistido com um clique pela recepcionista; a partir da semana 8, os disparos tornam-se 100% automáticos.

Lista de espera



Fila prioritária organizada por horário e preferência do paciente. Assim que uma vaga é liberada por cancelamento tardio (menos que 24h), a oferta é disparada automaticamente via WhatsApp para o primeiro da fila.

Aba fisioterapeuta
Visão simplificada e restrita exclusivamente aos pacientes do profissional. Permite emitir relatórios de evolução para o convênio com poucos cliques e enviar vídeos de exercícios domiciliares.

Dashboard para Ricardo
Painel executivo de acesso exclusivo ao proprietário. Apresenta o indicador de faturamento perdido em cadeiras vazias e um simulador de premissas.

Escopo do piloto

O que entra:

- Plataforma Web com controle de acesso por perfil (RBAC): Aba da Recepção, Aba do Fisioterapeuta, Cadastro de Clientes e Dashboard do Ricardo.
- Automação de mensagens via WhatsApp Business API (Lista de Espera e Régua Educacional de Conscientização).
- Alerta de solicitação de renovação antecipada do convênio na 3ª sessão.

O que não entra:

- **Aplicativo Mobile:** Pacientes idosos possuem resistência a baixar novos aplicativos. O WhatsApp garante 100% de adesão sem fricção.
- **Integração Automática via API aos Portais de Convênio:** Requer alto custo de desenvolvimento e licenças que estourariam o orçamento de R$20 mil e o prazo de 10 semanas. A solicitação continua sendo feita no portal do convênio pela recepção, mas guiada pelos alertas do nosso sistema na 3ª sessão.

Estimativa de Esforço do Squad: Plano de 10 Semanas:

- **Semanas 1 a 2:** Discovery detalhado, alinhamento de requisitos, prototipação e validação das telas com Joana e os fisioterapeutas.
- **Semanas 3 a 6:** Desenvolvimento da Plataforma Web (Front-end, Back-end, controle de acesso RBAC e lógica de alertas da 3ª sessão).
- **Semanas 7 a 8:** Conexão com a API de WhatsApp, configuração das réguas de mensagens automatizadas e motor da Lista de Espera.
- **Semanas 9 a 10:** Testes de usabilidade, treinamento das equipes em Boa Viagem, homologação do piloto e apresentação dos resultados no Dashboard do Ricardo.

7. A proposta

7.1. Resposta para Ricardo

Prezado Ricardo, o prejuízo mensal de R$18.225,90 causado pelas consultas não realizadas na Clínica Movimento não é provocado somente, e nem principalmente, pelo esquecimento dos pacientes, já que esse fator representa apenas 13% dos abandonos, segundo a pesquisa com pacientes que interromperam o tratamento. O problema central

reside na ruptura na renovação dos convênios ao término da 5ª sessão, momento em que a falta salta de 18% para 44%, e, também, na percepção precoce de cura (30,4%).

A contratação da agência externa por R$15.000,00 mais R$400,00/mês em lembretes exige 4 meses para implementação e ataca uma causa secundária. Então, recomendamos a solução desenvolvida pelo squad 5 do CITi que entrega uma plataforma web com renovação antecipada na 3ª sessão e lista de espera ativa por R$18.000,00 totais no 1º ano, pronta em 10 semanas e com tempo de retorno (payback) estimado em 2,1 meses.

7.2. Comparação com a proposta da agência

	Proposta da agência terceira	**Solução proposta pelo squad CITi**
Foco	Agendamento genérico e envio manual/passivo de lembretes.	Controle automatizado das sessões autorizadas e alertas antecipados para renovação, configuráveis de acordo com as regras de cada convênio, conscientização clínica e fila de espera ativa.
Causa atacada	Esquecimento (responde por apenas 13% das faltas).	Ruptura do convênio na 5ª sessão (44% no-show na 6ª) e abandono por melhora sintomática.
Investimento	R$15.000,00 (setup) + R$4.800,00 (anual) = **R$19.800,00**.	**R$18.000,00** (Projeto Squad 10 sem. + Infraestrutura no 1º ano).
Prazo de entrega	4 meses (16 semanas).	**10 semanas (Piloto em operação em 2,5 meses)**.
Retorno estimado	Indeterminado (não reduz o gargalo financeiro de convênio)	**2,1 meses pós-implantação** (Rápida recuperação de receita).

7.3. Custo e Retorno

Custo total: R$18.000,00, ficando dentro do limite orçamentário de R$20 mil.

Meta em 3 meses pós-lançamento:

- **Boa Viagem:** Redução da taxa de faltas de 25% para 12%
    - recuperação de 78 sessões/mês × R$77,00 = R$6.006,00/mês.
- **Casa Forte:** Redução da taxa de faltas de 17% para 10%
    - recuperação de 29,4 sessões/mês × R$93,50 = R$2.748,90/mês.
- **Receita mensal total recuperada:** R$8.754,90 / mês.

Tempo de retorno (Payback):
R$18.000,00 / R$8.754,90 por mês ~= 2,05 meses

Retorno(ROI no 1º Ano - 9 meses de operação pós-piloto):
((9 x R$8.754,90) - R$18.000,00) x 100 / R$18.000,00 = 337,7%

As projeções dependem do alcance das metas e pressupõem que as sessões recuperadas sejam efetivamente realizadas. O cálculo também considera o mix estimado de pacientes por modalidade; portanto, os valores representam potencial de faturamento bruto, não lucro líquido.

O piloto terá duração de 10 semanas, conforme o cronograma de desenvolvimento apresentado na seção 6. A implantação inicial ocorrerá em Boa Viagem, com expansão para Casa Forte após a validação dos resultados. A expansão para Casa Forte ocorrerá após a validação do piloto.

8. Riscos e perguntas em aberto

8.1. O que pode dar errado

Atraso excessivo da operadora de convênio (> 10 dias úteis):
Como resolvemos: Configurar o alerta de laudo de evolução para a 2ª sessão nas operadoras com histórico de maior lentidão.

Resistência operacional da equipe ao novo sistema
Como resolvemos: Interface simplificada por perfil de acesso, eliminando redundância de digitação e operando com ações de um clique.

Baixo engajamento ou não leitura das mensagens por idosos
Como resolvemos: Funcionalidade de cadastro de responsável, enviando simultaneamente as notificações e lembretes da trilha.

8.2. O que ainda não sabemos

Proporção exata de desmarcações tardias: Qual percentual das 150 faltas mensais de Boa Viagem corresponde a cancelamentos informados com menos de 24h em comparação com o absenteísmo total sem aviso.
Demanda e viabilidade operacional do atendimento aos sábados: Qual seria a adesão real dos pacientes que relatam incompatibilidade de horário em dias úteis e a viabilidade financeira de abrir a clínica no fim de semana.

9. Quem fez o quê

Nome	Área de escolha	O que fez	Revisou
Ana Beatriz	Problema e Pessoas	Mapeou e desenhou a Jornada do Usuário e identificou quem é afetado, stakeholders e o que cada pessoa precisa	Dados e Impacto, impacto financeiro e registros de falta.
Bruno	Dados e Impacto	Calculou o impacto financeiro mensal/anual das faltas por unidade e mapeou as limitações dos dados. Identificou divergências entre dados e entrevistas	Solução e protótipo, proposta ao cliente e apêndice de cálculos.
Gabriel	Problema e Pessoas	Mapeou e desenhou o fluxograma AS-IS e identificou as dores, quem é afetado, stakeholders e o que cada pessoa precisa; Fez o apêndice	Dados e Impacto, fluxograma TO-BE e Documento oficial (com ênfase nos tópicos 2 e 5)
Giovanna	Dados e Impacto	Estruturou as causas principais das faltas, o tratamento das divergências de registro entre unidades e organizou o documento oficial.	Validação funcional do protótipo, divergências de dados e a solução final.
João	Solução e Protótipo	Desenhou o protótipo de média/baixa fidelidade da solução principal e definiu o escopo da ferramenta.	Causas principais, divergências entre fontes
Tom	Solução e Protótipo	Mapeou e desenhou o fluxograma do processo futuro (TO-BE) de agendamento, confirmação e renovação antecipada do convênio.	Jornada do Usuário e fluxograma AS-IS

Apêndice

Apêndice A: Cálculos do tópico "Os números"

Este apêndice apresenta as operações utilizadas para obter os indicadores financeiros e as estimativas comparativas entre as unidades da Clínica Movimento.

A.1. Estimativa de faltas mensais

- Boa Viagem: 600 × 25% = **150 faltas/mês**.
- Casa Forte: 420 × 17% = **71,4 faltas/mês**.

A.2. Receita média por sessão

- Boa Viagem: (60% × R$55,00) + (40% × R$110,00) = **R$77,00**.
- Casa Forte: (30% × R$55,00) + (70% × R$110,00) = **R$93,50**.

A.3. Faturamento potencial não realizado

- Boa Viagem: 150 × R$77,00 = **R$11.550,00/mês**.
- Casa Forte: 71,4 × R$93,50 = **R$6.675,90/mês**.

A.4. Impacto financeiro

- Mensal: R$11.550,00 + R$6.675,90 = **R$18.225,90**.
- Anual: R$18.225,90 × 12 = **R$218.710,80**.
- Participação de Boa Viagem: (R$11.550,00 ÷ R$18.225,90) × 100 = **63,4%**.

A.5. Comparação do perfil de pacientes

- Boa Viagem: (60% × 25,2%) + (40% × 15,5%) = **21,32%**.
- Casa Forte: (30% × 25,2%) + (70% × 15,5%) = **18,41%**.
- Diferença: 21,32% − 18,41% = **2,91 pontos percentuais**.

A.6. Concentração dos horários de pico

- **Boa Viagem:** 45% das sessões.
- **Casa Forte:** 35% das sessões.
- Diferença: 45% − 35% = **10 pontos percentuais**.

Observação: os dados apresentados permitem identificar essa diferença na distribuição dos horários, mas não permitem calcular isoladamente quantos pontos percentuais da taxa de faltas são provocados por ela.